



נוהל מס': 030.20
שם הנוהל: לידה במצג עכוז
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה מח' נשים ויולדות	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום:
	שם הנוהל: לידה במצג עכוז		דצמבר 2015
	כותב הנוהל: ד"ר אברהמי, ד"ר אהרונ		מהדורה: תאריך עדכון: 10.12.20
	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' זאב וינר	מאשר הנוהל: פרופ' זאב וינר	נספחים: טבלת טווח משקלי עובר
מס' דפים: 7	על החתום:	על החתום:	

תוכן העניינים

העמוד

הנושא

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | 1. רקע |
| 1 | 2. הגדרות ומונחים |
| 2 | 3. מטרות הנוהל |
| 2 | 4. סמכות ואחריות |
| 2 | 5. עקרונות הנוהל |
| 6 | 6. סימוכין |
| 7 | 7. נספחים |

1. רקע

- בלידה במועד נמצאים כ-3%-4% מכלל העוברים במצג עכוז. שיעור זה משתנה עם גיל ההיריון, ככל שגיל ההיריון עולה שיעור העוברים במצג עכוז יורד. בשבוע 32 שיעור מצג זה היינו 7%, ומתחת לשבוע 28 שיעור זה מגיע לכ-25% (1).
- שיעור תמותת העוברים סב-לידתית במצג עכוז גבוה פי 3-5 בהשוואה לעוברים הנולדים במצג ראש, ללא קשר לאופן הלידה (2).
- גורמי סיכון למצג עכוז כוללים: לידה מוקדמת, מומים עובריים, מומים רחמיים, ריבוי מי שפיר ומיקום שליה פתולוגי (2).
- בעבר הדעות היו חלוקות לגבי אופן לידת מצג עכוז בשל העדר ספרות מבוססת. בשנת 2000 פורסם ה- **Term Breech Trial (TBT)**, מאמר רנדומלי, רב-מרכזי, פרוספקטיבי, שהראה עלייה בתמותה ובתחלואה הנאונטלית בלידות עכוז נרתיקיות לעומת לידות עכוז קיסריות מתוכננות (3).
- לאחר פרסום מאמר ה- TBT, חלה ירידה משמעותית בלידות עכוז בעולם, לאור זאת חלה ירידה בניסיון המיילדים בניהול ויילוד לידות עכוז.
- בשנים שלאחר פרסום מחקר ה-TBT התברר שחלו כשלים בשיטות המחקר (4). כמו כן, פורסמו מחקרים רטרופקטיביים שהראו כי ניתן ליילד עוברים במצג עכוז באופן בטוח יחסי (5-8).
- בשנת 2006 פורסם מחקר ה- **PREMODA**, מחקר פרוספקטיבי תצפיתי שהציע שבמוסדות עם ניסיון בלידות עכוז נרתיקיות, וכאשר תנאים מחמירים מתקיימים לפני ובמהלך הלידה, לא קיים הבדל בתחלואה והתמותה העוברית בין עוברים שנולדו בלידה קיסרית לכאלה שנולדו בלידה נרתיקית (9).
- לפי הספרות האחרונה המובאת לעיל, לידת עכוז נרתיקית מתוכננת אפשרית בנשים עם בחירה מתאימה של היולדת.
- דיווחים רטרופקטיביים ופרוספקטיביים אחרונים של לידת עכוז נרתיקית לפי פרוטוקולים ספציפיים ציינו תוצאות נאונטליות מצוינות (4).
- כיום האיגוד הישראלי במיילדות וגינקולוגיה סבור שיש לאפשר לידה נרתיקית של עובר במצג עכוז בהעדר התווית נגד, בנוכחות צוות מיומן, ולאחר שהיולדת קיבלה הסבר והביעה את רצונה והסכמתה לכך (2).

2. הגדרות ומונחים:

- Frank Breech – כאשר עכוז העובר מוצג בתחתית הרחם, כשירכיו כפופות על הבטן ושוקיו מורמות. מצג זה מהווה כ-70% ממצגי העכוז.
- Complete Breech - כאשר הירכיים והברכיים בפלקסיה וכפות הרגליים בגובה העכוז.
- Incomplete and Footling Breech – כאשר הרגליים מתחת לגובה העכוז והן מובילות בתעלת הלידה.

נוהל מס': 030.20
שם הנוהל: לידה במצג עכוז
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



3. מטרת הנוהל:

בחירה וניהול של מקרים בהם ניתן ליילד נרתיקית עובר יחיד במצג עכוז.

4. סמכות ואחריות:

המוסמכים על ביצוע נוהל זה הם רופאי חדר לידה - רמב"ם (מתמחים ומומחים)
אשר הוסמכו על ידי מנהל המחלקה.
מנהל המחלקה הוא האחראי על ביצוע נאות של נוהל זה.

5. עקרונות הנוהל:

i. אבחנה:

- האבחנה של מצג עכוז יכולה להתבצע בבדיקה חיצונית או בבדיקה נרתיקית אך יש לאשרה בעל-שמע.

ii. התוויות נגד ליילוד נרתיקי של עובר במצג עכוז:

- חוסר הסכמתה של היולדת ללידת עכוז נרתיקית
- משקל עובר שהוערך בהערכה קלינית או על-שמע מעל 3,800 גרם או מתחת ל-1500 גרם (2).
- לציין בהערכת משקל 1500-750 גרם, מומלץ על יילוד בניתוח קיסרי (12).
- במשקלים מתחת ל-500 גרם, לאור סיכויי שרידות נמוך של היילוד (13), יומלץ על לידה נרתיקית.
- במשקלים שבין 500-750 גרם – ההמלצה על צורת הלידה תקבע על פי דיון עם היולדת תוך התחשבות בסיכויי ההישרדות של העובר, גיל ההיריון ורצון היולדת.
- עובר במצג רגליים
- זקיפות ראש של העובר בבדיקת על-שמע
- ניתוח קיסרי קודם
- כול סיבה שהיא אשר מהווה הורייית נגד ללידה נרתיקית

iii. התוויות נגד יחסיות ליילוד נרתיקי של עובר במצג עכוז:

- מבכירה – לציין שע"פ ניירות העמדה של האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה, ניתן לבצע לידת עכוז בגישה נרתיקית גם במבכירות בתנאי והיולדת עומדת בקריטריונים המופיעים בסעיף ההמלצות אך



נוהל מס': 030.20
שם הנוהל: לידה במצג עכוז
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

העדפה המחלקתית ברמב"ם היא שלא להמליץ על לידה נרתיקית במבכירות.

- ירידת מים ללא צירים
- כאשר קיים צורך בהפעלת לידה עם עובר במצג עכוז

הכנות לקראת לידת עכוז: .iv

- אנמנזה – היסטוריה מיילדותית, מהלך היריון נוכחי (בדיקות אבחון טרום לידתי, סקירת מערכות).
- בדיקה נרתיקית – בדיקה צווארית כולל פתיחה, מחיקה, גובה חלק מוביל של העובר.
- יש לבצע הערכת על-שמע הכוללת הערכת משקל ועמדת הראש לפני קבלת ההחלטה על אופן היילוד. בדיקת על-שמע תכלול:
 1. משקל העובר
 2. זקיפת הראש
 3. סוג מצג העכוז
 4. שלילת מצג חבל טבור.
- הרופא המיילד יעלה לדיון ניסיון מוקדם להיפוך חיצוני במידת האפשר.
- בעת קבלת יולדת עם עובר במצג עכוז יש להציג בפניה את הנתונים הבאים לגבי הסיכונים האפשריים בלידת עכוז אל מול לידה קיסרית ולתעד זאת בכתובים:

● מבחינת עוברית/יילוד:

- לידה נרתיקית של עובר במצג עכוז עלולה להעלות את התמותה הסב-לידתית והתחלואה המידית הניאונטלית
- עם זאת בבחירה זהירה של המקרים ובניהול הלידה, הסיכונים העובריים דומים לאלו של לידה קיסרית. במקרים אלו, שיעור התמותה הסב-לידתית הינו 2 ל 1000 לידות, ותחלואת היילוד המיידית 2 ל 100 לידות. יש לציין כי אין הבדל בתחלואה הנורולוגית לטווח רחוק בלידה נרתיקית לעומת לידה קיסרית (4).

● מבחינת אימהית:

- ניתוח קיסרי מתוכנן ביולדת עם מצג עכוז שאינה בלידה אינו מעלה את התחלואה האימהית בהשוואה ללידה נרתיקית עם זאת ניתוח קיסרי בלידה פעילה מעלה במקצת את התחלואה האימהית (2).

- אם תבחר היולדת בניסיון לידה נרתיקית, יש לקבל אישור לכך ממנהל חדר לידה או ממנהל אגף נשים ויולדות (או ממלא מקומו בהעדרו).

v. ניהול הלידה

- הלידה תנוהל בנוכחות שני רופאים אשר לפחות אחד מהם הינו רופא בכיר.
- מיילדת תהיה נוכחת בלידה.
- רופא ילדים יהיה נוכח בחדר לידה בזמן היילוד.
- רופא מרדים יהיה נוכח בחדר הלידה.
- ניתן לבצע כל אלחוש. עם זאת הרדמה אפידורלית עדיפה.
- יש לרוקן את שלפוחית שתן.
- יש לבצע ניטור עוברי ממושך.
- השראה/החשת לידה - על פי ניירות העמדה של האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה, ניתן לבצע השראת לידה והחשת לידה בהתאם להתוויות מילדותיות רגילות על-פי שיקוליו של הרופא הבכיר, אך ההעדפה המחלקתית ברמב"ם היא שלא לבצע השראת לידה (אינדוקציה) במצג עכוז. עם זאת ניתן לבצע החשת לידה (אוגמנטציה) ע"פ הצורך.
- במקרה של חוסר התקדמות של הלידה יש לבצע לידה קיסרית.
- בכל שלב בלידה הנרתיקית המתוכננת, כאשר היולדת מבקשת לבצע ניתוח קיסרי, יש לבצעו, אלא אם התנאים ו/או מצבה הרפואי מהווים התווית נגד לביצוע ניתוח כזה.

vi. טכניקת לידה - המלצות:

- עדיף להימנע מפקיעת מי שפיר עד פתיחה גמורה.
- במידת האפשר יש לאפשר התקדמות ספונטנית של הלידה עד יציאת הזרועות (במידה וניטור עוברי תקין).
- בזמן לידת הראש, לחץ סופרא-פובי יכול לסייע בפלקציה של הראש ולהקל על יציאת העובר.
- ניתן להיעזר בשיטת Lovest לחילוץ זרועות עורפיות.
- ניתן להיעזר בתמרון ע"ש Mauriceau או Bracht לחילוץ הראש.
- ניתן להיעזר במלקחי PIPER לחילוץ הראש.

נוהל מס': 030.20
שם הנוהל: לידה במצב עכוז
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



6. סימוכין

1. Collea JV: Current management of breech presentation. Clin obstet Gynecol 23: 525, 1980.
2. נייר עמדה מס 2 – לידה במצב עכוז, ההסתדרות הרפואית בישראל – האיגוד הישראלי למיילדות לגניקולוגיה, מרץ 2003
3. Hannah ME, Hannah WJ, Hewson SA, Hodnett ED, Saigal S, Willan AR, et al. Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomised multicentre trial. Lancet 2000;356:1375–83. 7.
4. SOGC Clinical Practice Guidelines-Vaginal Delivery of Breech Presentation No. 226, June 2009
5. Giuliani A, Scholl WMJ, Basver A, Tamussino KF. Mode of delivery and outcome of 699 term singleton breech deliveries at a single center. Am J Obstet Gynecol 2002;187:1694–8.
6. Hellsten C, Lindqvist PG, Olofsson P. Vaginal breech delivery: is it still an option? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;111:122–8.
7. Kayem G, Goffinet F, Clement D, Hessabi M, Cabrol D. Breech presentation at term: morbidity and mortality according to the type of delivery at Port Royal Maternity hospital from 1993 through 1999. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002;102:137–42.
8. Alarab M, Regan C, O'Connell MP, Keane DP, O'Herlihy C, Foley ME. Singleton vaginal delivery at term: still a safe option. Obstet Gynecol 2004;103:407–12.
9. Goffinet F, Carayol M, Foidart JM, Alexander S, Uzan S, Subtil D, et al. PREMODA Study Group. Is planned vaginal delivery for breech presentation at term still an option? Results of an observational prospective survey in France and Belgium. Am J Obstet Gynecol 2006;194:1002–11.
10. ACOG Mode of Term Singleton Breech Delivery, Number 340, July 2006, reaffirmed 2014.
11. RCOG Guideline No. 20b 10 of 13 Evidence level IV Evidence level IV
12. Ulstein M: Breech delivery. Ann Chir Gynaecol Fenn 69:70, 1980.
13. נייר עמדה מס 27 – ניהול לידה בגבול החיות, ההסתדרות הרפואית בישראל – האיגוד הישראלי למיילדות לגניקולוגיה, מאי 2011

נוהל מס': 030.20
שם הנוהל: לידה במצג עכוז
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם

7. נספח

מקור	גבול משקל תחתון	גבול משקל עליון
האיגוד הישראלי	1500	3800
ACOG	2500	4000
RCOG	2000	3800
SCOG	2500	4000
CNGOF	2500	3800
GABBE	2000	3800
PREMODA (91.4%)	2500	4000
טווח	1500-2500	3800-4000